

中国高龄脑卒中患者康复治疗技术专家共识

中国老年保健医学研究会老龄健康服务与标准化分会
《中国老年保健医学》杂志编辑委员会 北京小汤山康复医院



扫一扫下载指南原文

【关键词】 高龄 脑卒中 康复 专家共识

doi: 10.3969/j.issn.1672-2671.2019.01.001

1. 概述

1.1 背景随着社会老龄化的加剧,中国的老年人口比例迅速增加,至 2017 年底 60 岁以上人口已达 2.4 亿。脑卒中是导致老年人死亡率增高和遗留身体残疾的最常见病因,严重影响患者的生活质量。1982 年联合国世界老龄问题大会上提出 80 岁以上人口为高龄老年人,我国的标准与此一致,高龄老年脑卒中即指 80 岁以上的脑卒中患者。高龄脑卒中患者由于系统及脏器功能衰退、体力耐力下降、代偿功能差,且往往合并多种疾病,其功能障碍有如下特点:①病程较长,恢复慢,容易遗留后遗症。②共病较多,病情复杂,治疗矛盾。③容易出现褥疮、坠积性肺炎、水电解质紊乱、意识障碍及全身衰竭等严重并发症。因此,除了正确合理的药物治疗、精心周到的护理措施外,更需要全面、综合、有效的康复治疗以改善患者的功能障碍,减轻残损残疾障碍,提高患者的生活质量及预后。

1.2 建设目的及意义随着神经科学技术和康复医学的发展,国内外老年脑卒中康复领域专家对高龄脑卒中的医学管理、康复理念及康复治疗技术等方面进行了深入综合的研究,越来越多的国内外专家学者倾向采用循证医学依据来选择高龄脑卒中的评价方法和康复治疗技术手段。高龄脑卒中患者常出现多种功能障碍或并发症如运动功能障碍、认知心理障碍、言语吞咽障碍、心肺功能障碍、感染及营养不良等,病情相对复杂,故针对高龄脑卒中患者的康复,应进行全面地综合评估,并根据具体情况制定适宜的个性化整体康复目标。

建设及制订中国高龄脑卒中康复治疗技术专家共识最重要的目的是为中国高龄脑卒中康复治疗的实施和评价提供一个科学的证据基础,规范高龄脑卒中患者的康复治疗行为,帮助相关医疗机构按照循证医学支持的康复治疗方、标准及规范进行操作。中国高龄脑卒中康复治疗技术专家共识能够明晰康复技术和研究的效果,合理分配治疗资源,以循证依据进一步指导临床实践,使高龄脑卒中患者获得最大限度的功能改善和最大程度的自理能力,对提高患者生活质量,防止复发和减轻社会负担等方面具有重要意义。

2. 高龄脑卒中患者的康复实施条件

2.1 场地与设备针对高龄脑卒中患者康复的场地,康复科室设置及布局要满足高龄脑卒中的康复特点,也就是康复科室要设置全面、康复场地布局合理、无障碍设施齐全和配有急救设备等。对于康复科室设置要具备临床科室、康复评定科室、康复治疗科室和相关医技科室。临床科室应有神经科、心内

科、呼吸科和中医科等临床科室,并与急诊科室做好相关应急预案。康复评定科室要能开展肢体功能评定、平衡协调功能评定、认知功能评定、作业日常生活能力评定等在内的康复评定工作。康复治疗科室要包含物理治疗室、作业治疗室、言语治疗室、康复工程室和传统康复治疗室等,有条件可以开设心理康复室。设备方面要满足临床医疗、康复治疗 and 康复护理等基本需求,并逐步从基础设备过度到专业化设备,例如临床医疗设备包括病床、供氧设备、监护设备、呼吸设备和抢救设备等;康复治疗设备包含康复评定设备、运动治疗设备、作业治疗设备、言语治疗设备、物理因子设备、康复工程设备等。

2.2 人员要求康复机构人才队伍中,要根据床位数量,配备相应人员,要满足医师人数 0.15 名/床,副高以上专业技术任职资格人数不少于 10%,康复治疗师人数 0.25 名/床,护士人数 0.3 名/床,营养师 2 名。康复专业人才队伍建设是高龄脑卒中患者康复人员要求的首要目标,康复医学专业人员特别是康复医师、康复治疗师和康复护士的缺口仍较大,尤其是具有正规执业资质的康复医师及康复治疗师在部分机构中仍严重缺乏。康复医师原则上不低于本科学历,康复治疗师和康复护士原则上不低于专科学历。

2.3 应急措施高龄脑卒中患者康复的应急措施包括:每 10 张病床配备一套抢救设备,定期对医务人员进行心肺复苏术(CPR)培训,与本院急诊科及 ICU 等相关科室建立应急合作模式,完善应急预案,并在入院时填写信息统计表,包括入院日期、住院号、住院科室、姓名、性别、年龄、民族、居住地址、入院诊断、紧急联系人等内容。

2.4 建设模式与案例高龄脑卒中患者的康复模式,应建立综合康复医疗小组,建立以不同专业领域(临床、康复治疗、康复护理)为主导,以患者为中心的多专业协作小组,并参考卒中单元多学科诊治模式,建立康复医学小组,实现多学科联合诊治,使治疗、康复、营养等多方面联合为患者诊治。康复治疗小组由康复科主任担任组长,成员包括主管医师、康复治疗师和康复护士。组长负责部门间的沟通、协调,小组工作制度的制订和团队管理,必要时联系其他学科协助治疗。主管医师、康复治疗师、康复护士负责脑卒中患者病情评估、功能障碍评定、肢体功能训练和康复护理等康复计划的制订和实施。以中国中医科学院望京医院为例,康复中心主任为组长,在患者的临床治疗阶段,主管医师为主导,负责患者疾病的诊断和治疗,其他成员(康复治疗师、护士)配合医生完成相应临床治疗工作;在患者的康复治疗阶段,康复治疗师为主导,负责

患者功能障碍的评估和治疗,其他成员(主管医师、护士)配合治疗师完成该阶段的治疗工作;在康复护理方面,护士为主导,其他成员(主管医师、治疗师)需配合治疗,组内成员各司其职,负责好本专业的治疗工作,共同完成高龄脑卒中患者的康复治疗。

3. 高龄脑卒中患者康复流程

3.1 患者评估

3.1.1 采用工具:对于高龄老年患者的卒中评价,推荐采用国际通用的评价工具,在具备协调和科室结构健全的医疗机构中为患者进行全面系统的评估,为进行正确适当的各种临床处理提供依据。这些评估工具有助于保证对患者的神经功能状况、残疾程度、功能独立性、家庭支持、生活质量、障碍转归提供帮助。

3.1.2 评价内容:高龄患者由于年龄大,基础病多,并发症风

险高,因此评估应尽可能全面,包括现存的功能障碍:意识水平、精神状态、认知、言语、吞咽、营养、皮肤、心理、日常生活能力、疼痛、辅助和适应性工具、肢体运动、平衡评定、肌容积、骨密度、二便、心肺功能、内科合并症评定等方面。

3.1.3 评价人员:由医院组成多学科康复小组进行评价,康复小组可由相关医师(内科、外科等专业技术人员)、康复医师、治疗师、护士组成,并贯穿于患者康复的全过程。护理院及社区的康复人员应尽可能全面且专职,对进入社区康复的患者进行评价。高龄患者由于常合并其他疾病,病史采集及体格检查要全面,必要时多学科协作评估并记录文案。一旦患者病情稳定,首诊医师应咨询相关部门,根据需求进行多学科协作,转至康复小组进行评价。

3.2 高龄脑卒中患者康复流程图 图 1。

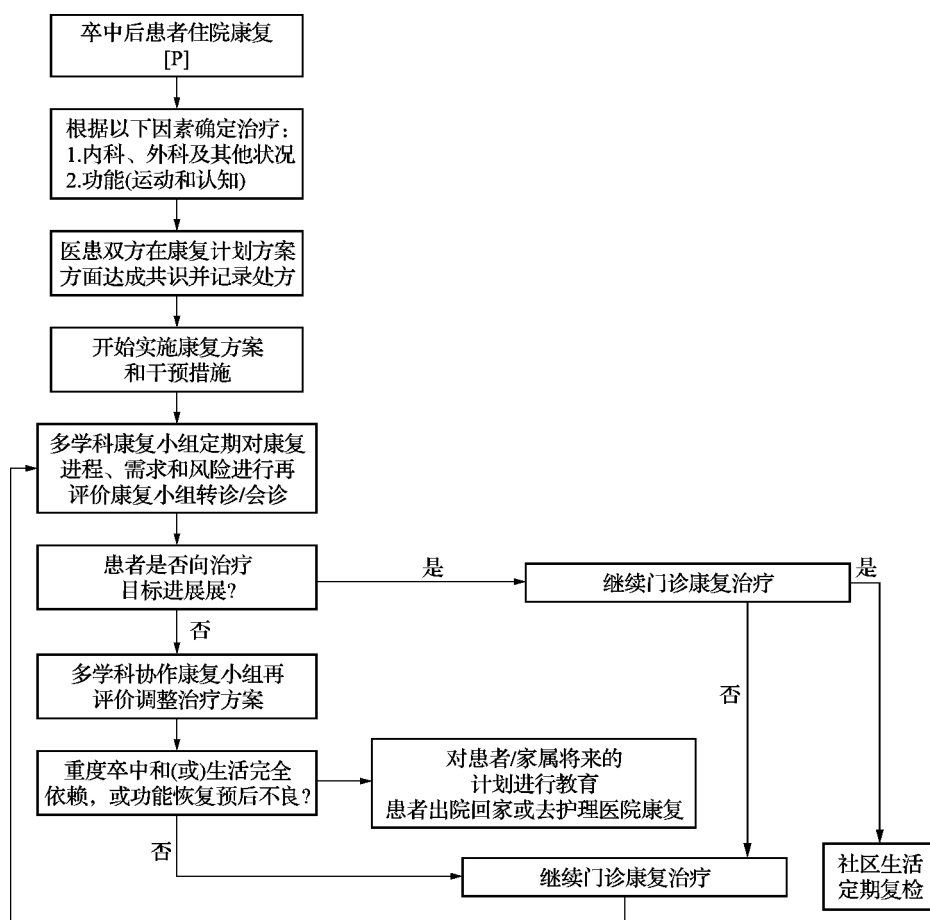


图 1

4. 高龄脑卒中患者康复评定

4.1 高龄脑卒中患者功能障碍评定的特点及评定方式的选择策略高龄脑卒中患者的功能障碍可分为原发性和继发性两大类。原发性功能障碍是指卒中受损脑区直接导致的相应功能降低或缺失,主要包括运动障碍、感觉障碍、认知障碍、语言障碍、吞咽障碍等。继发性功能障碍则是由于卒中后合并的或伴随的功能障碍,包括疼痛、骨质疏松、衰弱、肩关节半脱

位、压疮、情绪障碍和睡眠障碍等。因此,高龄脑卒中患者功能障碍评定时,应针对上述原发性和继发性的各种功能障碍逐一进行。

对高龄脑卒中患者进行评定时,要特别关注血压变化和心肺功能,应及时进行膀胱功能评价,主要进行尿流动力学检查。不同部位骨折所致功能障碍常延误卒中康复,尤其腕部骨折,严重影响患者站立和行走功能^[4],因此要特别关注高龄

脑卒中患者的跌倒风险。针对视听觉较差且认知功能减退的患者,评定时要有耐心,必要时反复多次说明。听力明显减退时,可应用书面文字进行补充解释,以保证高龄脑卒中患者理解评定任务和内容,提高评估的准确性。多数高龄脑卒中患者常患有衰弱综合征,身体和脑力容易疲劳,每次评定时间不宜过长,当受试者注意力不集中或感觉疲惫不适时,应暂时终止评定,待其恢复后再继续评定。

4.2 高龄脑卒中患者康复评定相关量表 高龄脑卒中患者康复评定包括原发性功能障碍评定、继发性功能障碍评定、日常生活能力及生活质量等方面的评定。各个方面的具体量表如下。

4.2.1 原发性功能障碍康复评定相关量表:原发性功能障碍主要指脑卒中本身所致的运动障碍、感觉障碍、认知障碍、情绪障碍、语言障碍、吞咽障碍等。美国卫生保健政策研究所(AHCPR)卒中后康复指南和中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)^[9]推荐,应用NIHSS量表进行评定,根据评分指导制定急性脑卒中的康复治疗方案,判断脑卒中的严重程度和可能的预后,并对患者进行分层。①运动障碍:应用Brunnstrom分期、Fugl-Meyer评定量表、运动评估量表(the motor assessment scale,MAS)进行整体运动功能评价。Fugl-Meyer评定量表包括肢体运动、平衡、感觉、关节活动度和疼痛5项,共113个小项目,每个小项目分为3级,分别计0分、1分、2分,总分226分,其中运动功能积分为100分(上肢66分,下肢34分)、平衡14分、感觉24分、关节活动度44分和疼痛44分,常用的简化Fugl-Meyer评定量表只评定肢体运动功能。运动评估量表(the motor assessment scale,MAS)评定法,主要用于评估患者功能活动能力,而不是单纯的协同运动模式,包括从仰卧到健侧卧、从仰卧到床边坐、坐位平衡、从坐到站立、步行、上肢功能、手的运动、手精细活动和全身肌张力9项内容,为6级评分,1~6级分别为1~6分,达不到1级为0分,肌张力项评分不列入总分,仅作参考,其余8项满分为48分,评分越高则运动功能越好。通过徒手肌力检查、Ashworth痉挛评定量表、Berg平衡量表(Berg Balance Scale,BBS)、Fugl-Meyer平衡量表、计时起立-步行测验(timed up and go test,TUGT)、威斯康星步态量表(Wisconsin gait scale,WGS)等分别进行肌力、肌张力、平衡协调能力及步行能力的评定。②感觉障碍:躯体感觉检查包括浅感觉(痛、温、触觉)、深感觉(位置觉、运动觉和振动觉)和皮层复合觉(图形觉、实体觉、两点辨别觉、重量觉和定位觉),可采用Fugl-Meyer量表进行感觉评定。③认知障碍:老龄化、受教育水平、糖尿病、运动障碍、皮质下多发梗死被认为是脑卒中后认知障碍危险因素^[9]。多采用量表评定认知功能,常用简易精神状态检查(Mini-Mental State Examination,MMSE)和蒙特利尔认知评估量表(Montreal Cognition Assessment,MoCA)进行筛查,详细综合的测试可应用洛文斯顿作业疗法认知评定量表(Lowenstein Occupational therapy cognitive assessment,LOTCA)。上述神经心理学量表在评定认知功能方面各具优点,但主观性较强,容易受到患者配合程度及文化水平的影响。近几年来有学者将影像学及神

经电生理学技术运用于认知障碍评定,影像学手段主要包括磁共振功能成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)、计算机单光子发射体层扫描成像(Computed Tomography,CT)。神经电生理检查主要是检测患者事件相关电位中的P300电位。将神经心理学量表评定与影像学及神经电生理学相结合,可有效提高认知障碍的检出率,对认知障碍的康复更具指导意义。④语言障碍:语言障碍包括失语症和构音障碍两部分。失语症评估的常用评估量表有,西部失语成套(Western Aphasia Battery,WAB)测验和中国康复研究中心失语症检查法(China Rehabilitation Research Center Aphasia Examinant,CRR-CAE),也可应用汉语失语症成套测验(Aphasia Battery of Chinese,ABC)。需从听、说、读、写、命名和复述等多方面的综合评估失语症的类型和严重程度。构音障碍的评价常用中国康复中心构音障碍检查表和汉语版Frenchay构音障碍评价法。⑤吞咽障碍:洼田饮水试验和标准吞咽功能评价量表(Standardized Swallowing Assessment,SSA)为常用吞咽障碍筛查方法。进一步进行电视透视下吞咽能力检查(video fluoroscopic swallowing study,VFSS)和纤维光学内镜吞咽评估(fiberoptic endoscopic examination of swallowing,FEES)。VFSS都是吞咽障碍评估的金标准,FEES可以作为价格便宜、便于携带、结果可靠的VFSS的替代方法。

4.2.2 继发性功能障碍康复评定相关量表:继发性功能障碍包括疼痛、骨质疏松、衰弱、肩关节半脱位、压力性损伤、情绪障碍、睡眠障碍和肠和膀胱障碍等。①疼痛:高龄及脑卒中造成的疼痛包括痉挛、肌肉无力造成的关节痛、头痛、中枢性疼痛及肩痛,推荐采用视觉模拟法(Visual Analogue Scale,VAS)、数字分级法(Numerical Rating Scale,NRS)、简化麦吉尔疼痛问卷(short-form McGill Pain Questionnaire,SF-MPQ)对患者疼痛进行评价。②骨质疏松:高龄脑卒中患者定期进行骨密度测定,对骨质疏松的预防及治疗有很大帮助,降低因跌倒造成骨折的风险。通过跌倒风险指数(the Fall Risk Index,FRI)和修订版跌倒效能量表(Modified Falls Efficacy Scale,MFES)对跌倒风险进行评定,以便制定个体化的设施环境改造及安全教育。③衰弱:随着年龄增加,身体各系统功能减退,加之脑卒中后活动减少,多数高龄脑卒中患者常患有衰弱综合征,用老年综合评估量表(comprehensive geriatric assessment,CGA)评估患者的衰弱综合征状态,依据老年综合评估量表得出衰弱指数(frailty index,FI)(FI-CGA),并将其分为3个等级:0~7为轻度,8~13为中度,13分以上为重度。④肩关节半脱位:肩关节半脱位的评定方法有多种,应用较多的是通过肩关节正侧位X线检查测量肩峰下缘与肱骨头关节面之间的最短距离及肩峰下缘中点与肱骨头中心之间的距离。⑤压力性损伤:建议对高龄脑卒中患者进行压力性损伤危险性评估,至少每天检测1次,可采用Braden量表从患者的感觉、皮肤潮湿、活动、移动、营养状况、摩擦力和剪切力6个方面进行评估,分数低表示危险增加。⑥情绪障碍:全面情绪障碍评定包括患者心理疾病、病前性格特点、病前社会地位及相关社会支持情况。应用汉密尔顿焦虑量表(Hamilton Anxiety-

ty Scale, HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale, HAMD)进行高龄脑卒中后焦虑抑郁评定。汉密尔顿焦虑量表包括 14 项,所有项目采用 0~4 分的 5 级评分法:总分 ≥ 29 分,可能为严重焦虑;总分 21~28 分,肯定有明显焦虑;总分 14~20 分,肯定有焦虑;总分 7~13 分,可能有焦虑;总分 < 7 分,没有焦虑症状。汉密尔顿抑郁量表包括 24 项,总分 > 24 分重度抑郁;18~24 分中度抑郁;7~17 分轻度抑郁; < 7 分无抑郁。⑦睡眠障碍:与其他人群相比较,老年睡眠障碍患者的发病率更高,临床上对失眠的治疗主要以使用地西泮等苯二氮卓类药物为主,推荐使用匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh sleep quality index, PSQI)综合评估高龄脑卒中患者的睡眠质量。PSQI 用于评定患者最近 1 个月的睡眠质量,由 19 个自评和 5 个他评条目构成,总分范围为 0~21,得分越高表示睡眠质量越差:0~5 分提示睡眠质量很好,6~10 分提示睡眠质量尚可,11~15 分提示睡眠质量一般,16~21 分提示睡眠质量很差。⑧肠和膀胱障碍:随着年龄增加,老年人的食量和体力活动明显减少,胃肠道分泌消化液减少,肠管的张力和蠕动减弱,直肠敏感性下降,易引起便秘等肠和膀胱障碍,推荐使用膀胱/直肠功能测评表,该量表参照扩展残疾状态量表(Expanded Disability Status Scale, EDSS)的具体评价内容,主要由尿延迟/尿潴留、尿急/尿失禁、导尿及直肠功能 4 项目组成,障碍程度包括轻、中、重和功能丧失^[1]。

4.2.3 日常生活能力评定相关量表:日常生活活动能力(activities of daily living, ADL)是指人们在日常生活中进行各项活动的的能力,分为基本日常生活活动能力(basic activities of daily living, BADL)与工具性日常生活活动能力(instrumental activities of daily living, IADL)。常用的 BADL 量表评定方法有 Barthel 指数(Barthel index, BI)、功能独立性测量(Functional Independence Measurement, FIM)等, IADL 评定量表有 Frenchay 活动指数、功能活动性问卷等^[14]。其中 Barthel 指数评定量表包括进食、洗澡、穿衣、大便控制、小便控制、用厕、床椅转移、平地行走和上下楼梯 10 项内容,每个项目分数为 5~15 分,根据是否需要帮助及帮助的程度给分,总分为 100 分。得分越高,独立能力越好:0~20 分为功能严重障碍,日常生活完全依赖;21~40 分为生活需要很大帮助,属重度依赖;41~60 分为生活需要中等程度帮助;60 分以上为生活大部分自理;100 分为基本生活独立自理,不需他人照顾。FIM 量表包括 13 项运动功能和 5 项认知功能,最高分为 126 分(运动功能评分 91 分,认知功能评分 35 分),最低分 18 分;126 分为完全独立,108~125 分为基本独立,90~107 分为有条件的独立或极轻度依赖,72~89 分轻度依赖,54~71 分中度依赖,36~53 分为重度依赖,19~35 分为极重度依赖,18 分为完全依赖。

4.2.4 生活质量评定相关量表:可用于卒中生活质量评定的量表有卒中专用生活质量量表(stroke-specific quality of life, SS-QOL)、诺丁汉健康调查表(nottingham health profile, NHP)、卒中影响量表(stroke impact scale, SIS)、健康状况调查问卷 SF-36((The Short Form-36 Health Survey, SF-36)等。

5. 高龄脑卒中患者康复治疗技术

5.1 高龄脑卒中患者康复运动处方经过中外文献检索,目前尚没有检索到关于 80 岁以上高龄中风老人运动处方治疗指南实证研究资料,甚至针对 80 岁以上老年中风患者运动锻炼的论文资料都非常少,涉及包含高龄脑卒中老人的论文中病例数也较少,缺乏随机对照实验。因此,本部分仅限于根据零星资料和对老年病患者的资料整理。这也是为什么需要关注高龄老年中风患者的目的之一。

5.1.1 高龄老年脑卒中患者的患病特点:①80 岁以上高龄老年脑卒中特点有别于低龄脑卒中者:高龄脑卒中者在病理上表现为多发的小血管源脑损伤,心房纤颤等心源性因素占比较大。②痴呆发生率较高:高龄老人脑卒中前已患有痴呆者占 10%,病后 1~3 年发生痴呆者进一步增加,高达 10%~30%。③虚弱症多:虚弱症指患者肌肉质量和力量下降,易疲劳,运动能力如步行速度下降,易跌倒,影响老年人生活活动。研究显示,85 岁以上老年人中 25%~50% 患有虚弱症,其中包含肌少症(肌肉质量和力量的降低),肌肉力量和爆发力的降低比肌肉质量的降低对老年人功能障碍影响更重要,中风后跌倒率较健康老年人大幅提升。④心血管疾病危险因素多,心血管疾病发病率高:高龄老年人中心血管危险因素(高血脂、高血压、体重大、糖尿病等)更多,心血管疾病发病率也进一步随增龄增加。⑤高龄老年脑卒中患者合并症更多。脑卒中后高龄老年人合并症会更多,这也是虚弱的表现,应激能力下降。⑥高龄老年脑卒中患者服药多:高龄老年人平时用药较多以维持健康,发生脑卒中后药物应用进一步增加。所有这些因素都加剧并复杂化了高龄脑卒中患者运动功能障碍,包括肢体瘫痪,心肺耐力低,肌力差,易跌倒,卧床时间长,致使他们残疾程度更重或者残疾发病率高。

5.1.2 高龄老年脑卒中患者的运动处方:(1)运动目的:为高龄脑卒中老年人制订运动处方的目的是提升他们的运动功能和体力,减少卧床及合并症,增强平衡功能,预防跌倒,提升步行等 ADL 能力,提高生活质量,同时要特别考虑认知功能和药物的影响。(2)运动训练的原则:高龄老年脑卒中患者运动训练应该遵循个体化、循序渐进、持之以恒的原则。(3)运动训练方式:在疾病不同时期采用不同的方式,总体来讲有被动训练、神经肌肉电刺激、辅助主动训练、机器人辅助行走和手臂功能训练、运动平板或功率车主动训练、太极拳锻炼、步行训练、肌肉力量训练、平衡训练、功能性训练,水疗等。根据患者病情和康复需求选择需要的、可行的、喜爱的训练方式,一般应该包括有氧耐力训练、力量训练、平衡训练、关节灵活性训练和功能性训练,不能主动训练时可进行辅助或被动训练。(4)运动方案:在急性期以被动训练为主,各个肢体关节,尤其是患肢每个关节全范围活动 3~5 次,2 次/天,每周 7 天,以保持关节活动度和刺激运动感觉;亚急性期或慢性期可以进行助力运动训练或主动训练,其强度可设定为静息心率 + 20 次,逐渐过渡到 30%~40% HRR [心率储备: (HRmax - HRrest) $\times$ 30%~40% + HRres] 低强度训练,或者再过渡到 40%~60% HRR 中等强度运动训练。也可用主观用力程度

(Borg 量表-RPE) 来确定运动强度: 9~11 为低强度轻松运动, 12~15 为中等水平有氧运动强度范围; 谈话试验也是低中强度运动, 表现为在运动训练中能够交谈, 没有明显气短费力。运动时间为 20~40 分钟/次, 根据患者情况运动时间可以少量多次累加; 运动频率为 3~5 次/周, 取决于患者患病时期、体力耐受情况和康复目标。持续训练可以显著增加中轻度中风患者步速、步行耐力、有氧适能($\text{VO}_{2\text{peak}}$) 和体力活动水平, 一般训练 1~6 个月即可显效。研究提示, 12~18 周的有氧耐力运动联合力量训练对轻度认知障碍的高龄老人(包括中风所致) 执行力有一定效果, 有氧运动联合视频认知教育活动也可改善轻度认知障碍高龄老人的记忆力。(5) 注意事项: ①一般建议患者生命体征稳定 48 小时开始运动, 运动过程中注意观察患者症状, 一旦患者主诉头晕、无力、心慌气短等, 或者治疗师观察患者有不适应症状, 如与运动锻炼不相称的气短、面色苍白、出汗、气促、无力等应及时终止运动, 让患者就近躺下休息, 及时呼叫医生, 并做快速的问诊、测量血压和心率等基础工作, 及时采取措施。即使生命体征稳定, 有运动试验禁忌症的患者也不宜开始运动治疗如动脉瘤、骨关节损伤未愈合、精神疾病未控制、深静脉血栓形成等。②运动过程中要加强监护, 主客观运动强度监测指标共用, 因为患者用药可能影响心率反应, 此时可以通过患者主观报告的 RPE 以及运动监护人的观察(如谈话试验、患者的症状等), 结合患者的心率反应监测共同确定患者训练强度是否适宜; 此外, 对患有痴呆的患者, 以运动监护者观察确定运动强度更合适。③运动训练中要注意防跌倒和防跌倒教育非常重要, 应该给予具体可行的指导措施, 如助行器的使用、避免天黑锻炼、训练中风险的判断及预防等。④多种运动训练方式交替进行非常必要, 有氧耐力训练有利于患者控制体重, 改善机体代谢, 减少运动功能下降导致的增重和代谢障碍。大肌群肌肉力量训练和快速力量训练也适用于慢性期高龄老年中风患者, 中低负荷, 每周 2~3 次, 可以改善肌肉力量和肌肉协调性。防跌倒训练如悬吊训练、快速反应训练等是高龄脑卒中患者最重要的运动训练内容, 每天 1 次, 每周 5 天, 有显著降低跌倒概率的效果。能够行走的高龄老年脑卒中患者步行能力差别很大, 步态异常, 步速慢, 步速变化范围大, 可低至 0.07m/s, 也可正常, 中度障碍者步速在 0.5m/s 左右, 因此, 步行稳定性训练非常重要, 他人辅助、机器人辅助或自行训练都可, 上述防跌倒训练、力量训练及功率车训练等也都有利于提高步速, 改善步行能力。⑤运动训练中需事先了解患者的病情及稳定情况、用药和训练中反应, 运动时监护, 并教育患者及陪护人员学会自我监测、救护和防摔倒的知识与方法。⑥在中风的急性期检查患者肢体运动活动量可以早期预测恢复期步行能力。

5.2 物理治疗

5.2.1 高龄脑卒中患者物理治疗概论: 物理治疗是通过运动与力、声、光、电、磁、水等物理因子刺激人体产生生理效应。临床上通常将物理治疗分为运动疗法和其他物理因子疗法两大类。运动疗法是脑血管疾病康复的主要治疗方法之一, 它

是借助于运动形式所产生的力这一物理因素, 依据大脑的可塑性、脑功能重组等理论基础, 使患者恢复和重新获得功能, 防止继发性功能障碍的康复治疗方法。物理因子疗法是高龄脑血管疾病患者康复治疗最常用的辅助手段, 具有安全、有效、舒适等特点。将物理因子作用于机体, 组织吸收物理能后, 产生局部、神经、血液、内分泌、免疫系统等生理、生化效应和治疗效应。高龄患者面临老化(或称衰老)、慢病、共病、失能等老年问题, 因此物理治疗应用于高龄脑卒中患者需考虑其复杂性和个体的异质性, 制定切实可行的目标, 实施简便易行的有效物理治疗。

5.2.2 高龄脑卒中患者应用物理治疗的适应症及禁忌症:

①适应症: 物理治疗适用于所有脑卒中患者。②禁忌症: 没有绝对禁忌。生命体征不稳定及症状持续进展时, 需延迟开始物理治疗时间。

5.2.3 高龄脑卒中患者应用物理治疗开始的时间: 病情稳定后就可以开始物理治疗。物理治疗要尽早介入, 与临床诊治同时进行。欧美国家关于脑卒中的康复治疗正在形成一个新的概念—very early mobilization(非常早期的活动)。对于没有严重并发症或脑水肿的患者, 在发病 24 小时内即开始床上活动。年龄、性别和卒中类型(出血、梗死)等并不影响脑卒中开始康复的时机, 即使患者处于昏迷状态或在重症监护室, 物理治疗仍需介入, 此时的物理治疗主要是被动的关节活动度维持、体位改变、良肢位摆放和促进排痰等。

5.2.4 高龄脑卒中患者应用物理治疗的特点: ①治疗量宜少量多次: 每次 15~30 分钟, 每天 2~3 次。对家属及照护人员进行培训, 获得他们的理解和积极配合。②治疗方法要灵活运用, 简便易行: 高龄患者活动能力降低, 心肺功能减退, 训练时需关注能量消耗, 以有氧运动为主, 合理安排训练内容。③训练内容要多重复: 老年人短期记忆及伴随的学习能力下降, 机能恢复也相对缓慢, 通过多重复和易化, 达到巩固的疗效。④严密观察并发症的发生: 通过体位改变、排痰等物理治疗方法, 预防压疮、肺部感染等并发症的发生。⑤瞄准治疗时机: 高龄患者病情多变, 易疲劳, 了解患者个体特点, 灵活推进康复进程。⑥尽早实施功能康复: 通过人工辅助, 辅助器具等尽早实现坐起、站立及行走等基本功能, 有效预防并发症及心肺功能的快速下降。

5.2.5 高龄脑卒中患者的急性期物理治疗: 脑卒中急性期持续时间一般为 2~4 周, 高龄患者这一时期可能会延续更长的时间。应用物理治疗的重点是积极处理原发病与各类并发症, 稳定病情, 缓解症状, 消除影响康复疗效的因素, 同时还要做好脑卒中及相关疾病的风险管理, 避免病情恶化。①正确体位摆放: 包括仰卧位、健侧卧位、患侧卧位都放置于良好的功能位及预防痉挛体位。②呼吸控制训练: 通过膈肌运动、缩唇呼吸训练, 增强呼吸的效能。③维持关节活动范围训练: 此期以被动活动为主, 逐渐过渡到主动辅助及主动运动。④翻身训练: 完成仰卧到健侧卧位、仰卧到患侧卧位的轴向翻身。⑤坐位训练: 从抬高床头的卧坐位到床旁坐位、无支撑坐位到完成坐位进食等功能性活动。⑥床椅的转移、轮椅的移乘训

练。⑦辅助下的坐和站立转换、支撑(应用平行杠、助步器或手杖)站立。

5.2.6 高龄脑卒中患者的恢复期物理治疗:恢复期患者病情相对稳定,功能逐渐恢复。宜积极实施以功能为导向的物理治疗。物理治疗的重点是从急性期的被动活动过渡到主动运动,同时要控制异常张力和运动模式的发生。①诱发肢体主动运动:应用神经发育疗法(包括 Bobath, Brunnstrom, Rood, PNF 等技术)诱发瘫痪肢体的主动运动。②物理因子治疗:应用经颅磁刺激,肌电生物反馈、低频电疗法,传导热疗法、水疗法、间歇式气压疗法等促进功能恢复、缓解痉挛、预防并发症等。③心肺功能训练:通过踏车、医疗体操等有氧运动,维持及改善高龄患者的心肺功能。④站立位平衡训练:除常规的平衡训练方法,还可采取躯干核心稳定训练,进一步提升平衡能力。⑤行走训练:依据患者的整体状况,制定适宜的目标。必要时训练使用助步器或手杖获得安全、实用的步行能力。

5.2.7 高龄脑卒中患者的后遗症期物理治疗:脑卒中具有高致残性,虽然经过积极的治疗,大多数患者仍会有肢体功能障碍,常见的后遗症主要表现为患侧上肢运动控制能力差和手功能障碍。此期的重点是维持日常生活活动,提高生活质量,回归生活,预防复发。①日常生活活动能力应用:最大限度地完成日常生活活动,必要时可借助辅助器具、家居改造。②维持性康复训练:通过持续的每周 3~5 次的综合物理治疗,达到延缓衰老,保留残存功能和生活能力的强化。

5.3 作业治疗作业治疗的主要目的是通过患者参与作业性治疗活动,改善和维持身体、心理两大方面的功能,适当改造家庭生活环境和社会环境,最大限度地提高患者的日常生活活动和社会活动参与能力。高龄脑卒中作业治疗的原则为早期介入、循序渐进、持之以恒、医患合作、系统管理和健康教育。设计治疗方案时,作业治疗师应具备全局观的意识和临床推理思维,以 OTPF 或 ICF 为构架,参考人-作业-环境模式(PEO)和加拿大作业表现模式(CMOP)等,体现以客户为中心的经营理念,通过技巧性访谈和规范化量表评定,详细评估患者的基础病情、体力耐受情况等,根据患者的目标和意愿,设计难度适中、能够引起患者兴趣的活动,让患者在参与作业活动过程中重建技能,必要时治疗师提供辅助器具帮助其代偿以达到功能的最大化。高龄脑卒中的作业活动主要包括生活自理和休闲娱乐。根据病情其作业治疗分为急性期、恢复期及后遗症期。

5.3.1 急性期作业治疗:一般指发病后的 1~4 周,治疗目标为改善患者受损的功能,预防各种并发症及继发障碍的出现,减轻残疾程度,视患者的病情可以进行基本日常生活活动的指导训练。治疗方法如下:①保持正确肢体位置及姿势:保持正确的卧位、坐姿和肢体位置能够有效预防或对抗痉挛姿势的出现和发展,可预防肩关节半脱位、早期诱发分离运动。正确的坐姿要求身体两侧对称,骨盆中立位并有稳定的支持,躯干保持直立位。治疗师必须随时纠正不良肢体位置和坐姿,并鼓励患者早日进行坐位下的作业活动。②关节活动度维持

训练和体位转换训练:详见物理治疗。③肩关节半脱位、肩痛、肩手综合征的预防及治疗:在发病早期即应给予正确的良肢位摆放,避免牵拉患肢,轻柔、正确地进行肩部的被动活动,注意保持正常的肩关节节律并避免产生疼痛。肌张力低下者可采用兴奋性的刺激,以促进肩关节周围稳定肌功能并增加肌张力,增加肩部的稳定性。痉挛所致的僵硬和肩痛者应注重改善肩胛骨和肩关节的活动度,可先进行被动运动,再逐步引导患者学习各种功能性活动,缓解痉挛和疼痛,所有活动均应在无痛下进行。

5.3.2 恢复期作业治疗:脑卒中发病后 1 个月左右进入恢复期,治疗目标为加强患肢的协调性和选择性随意运动,并结合患者日常生活活动进行实用功能的强化训练,适时应用辅助具,教授患者使用代偿性手段,以补偿患肢的功能,提高自理能力。治疗方法如下:①关节活动度的维持和改善训练:患者 Bobath 握手,借助磨砂板、滚筒等工具进行训练,调节磨砂板的角、磨具的重量、变换磨把等可增加训练难度,诱发患肢分离运动。②上肢和手的功能训练:应以抑制痉挛、促进分离运动的训练为主,包括上肢和手的运动控制能力训练,双手协调性训练,手指抓握及精细操作运动等。治疗师应设计上肢实用性运动模式组合,强调动作的准确性和双侧上肢参与,提高上肢运动功能。③感知觉功能训练:可采用特定感觉训练和感觉关联性训练以提高触觉和肌肉运动知觉等感觉能力。④预防和纠正半侧空间忽略:可采用视觉扫描训练、感觉觉醒训练、交叉促进训练等,并将训练融入到日常生活活动中。⑤姿势调控:包括姿势控制和维持平衡的能力,是能够完成作业活动的先决条件。作业治疗师尽量设计需双手参与,可引出躯干的运动和重心转移的作业活动,让患者尝试在多种姿势下进行,并通过姿势矫正镜增加视觉反馈,以训练适应身体不同体位变化的策略。⑥日常生活活动能力训练:详见日常生活指导。

5.3.3 后遗症期作业治疗:后遗症期多指发病后 1 年以上,治疗目标为加强现有和残存的功能,重视患者的环境适应训练,生活重建,最大限度地提高生活质量,使患者回归家庭、社会。治疗方法如下:(1)强化训练:①强化功能:继续进行上肢和手功能的作业治疗,提高整体日常生活活动能力的训练;②利手交换训练:如患手功能不可恢复或恢复很差,作业治疗师应设计专项训练,长时间、反复多次的训练,充分发挥健侧的代偿作用;③预防跌倒:高龄脑卒中患者可因运动功能障碍、平衡、协调能力下降,视力障碍,单侧忽略,意识混乱等因素导致跌倒风险增加,降低跌倒的风险可以通过发现并去除环境中的危险因素、运动控制训练、推荐合适的辅助器具等方法来实现。(2)健康教育:对患者、家属及照顾者进行疾病相关知识、正确转移方式、降低跌倒风险方法、每天的训练作业、常见问题以及应对方法等知识宣教,可增加患者及家属的配合程度,有效预防并发症的发生。(3)环境改造:高龄脑卒中患者具有行动不便、平衡、认知功能障碍、视知觉功能缺损、需要使用轮椅等特点,需进行家庭、社区环境下的适应训练,并对家庭环境做必要的改造,如去除门槛、加装扶手、改为坐式

便器等。(4) 辅助技术: 经过康复训练, 患者的某些功能活动难以恢复到独立正常进行时, 应指导患者使用辅助器具。如对餐具进行加工改造, 使用穿衣辅助具、足踝矫形器等, 增加或替代相应功能, 为患者更多地参与有意义的作业活动提供便利。(5) 生活重建: 虽然经过系统、正规的康复治疗, 仍有部分患者无法进行先前热爱的休闲活动和兴趣爱好, 无法回到原来的生活状态。作业治疗师需要根据患者的兴趣爱好、习惯和家庭条件、现有的功能状况及可掌握的资源, 通过活动调整和环境调整, 利用生活化的场景协助患者把功能转化为生活能力, 学习及实践适应性生活策略及方法, 重新建立一套与能力相适应的、能维持身心健康的生活方式。

5.4 心理治疗脑卒中是目前公认的心身疾病之一, 高龄脑卒中患者尤其应注意心理康复。因为患者面对疾病、自身活动能力和社会适应能力的下降, 难免发生心理负担, 如被抛弃感、悲观、猜疑、焦虑和抑郁、被动依赖感明显, 这些心理反应如果处理不当, 会使病情加重或反复。因此, 采取适当的康复心理对策是控制脑血管病患者症状、提高康复效果的重要环节。

5.4.1 心理问题分析: (1) 脑卒中患者的心理变化分期: 根据患者所表现出来的认知、情绪、行为等方面的特点, 可划分为否认期、抑郁期、被动依赖期、适应期等 4 个心理阶段。

①否认期: 否认指拒绝承认所处境况及其影响, 是个体用于应付痛苦的思想或情感的一种基本方式。患者面对自己的残疾或疾病抱有侥幸心理, 对病情产生部分或完全曲解以躲避心理负担与痛苦。临床表现为患者对康复治疗的期望过高, 常要求恢复到病前的身体状况, 不承认遗留残疾。该阶段患者的忧伤、悲观、苦闷的情绪较轻, 同时患者认为吃药打针就可以康复, 对康复治疗比较被动。②抑郁期: 随着时间的推移, 患者的疾病并没有向预期的方向转变, 意识到病情的严重性, 当幻想破灭后, 否认期可突然消失, 此时患者的抑郁情绪占主导地位, 临床表现为心情苦闷、沮丧、消沉、忧伤、无助甚至绝望等悲观情绪持久而突出, 甚至会出现自杀意愿。③被动依赖期: 从抑郁期过渡到被动依赖期, 大多数患者意志力减退, 主动性差、惰性强, 抑郁症状较少, 表现为对康复治疗不抱希望, 对他人依赖性增强, 不愿自我照顾, 凡事总依靠别人帮助, 懒散乏力、萎靡不振, 不愿进行康复训练。④适应期: 经过一段时间的康复训练, 患者了解到身体康复的可能性, 承认并接受自己残疾现实, 放弃不切实际的幻想, 对康复训练较为积极, 生活上尽可能减少依靠他人照顾, 能够理性分析并处理问题, 采取有效措施应付痛苦、悲伤、愤怒等情绪, 抑郁情绪减轻或消失。(2) 特殊心理问题: ①失落和孤独: 现代老年患者常因自己资历老、贡献大、经济好, 在位时与退休后角色的反差, 心里难免会产生失落感; 性格较前暴躁, 顺从性较差。喜欢周围的人能尊重并恭顺他们, 表现为自以为是、固执己见, 独断专行、易激怒、好挑剔责备他人; 有的老年患者特别害怕孤独寂寞, 在住院期间由于生活单调, 与家人及外界缺乏情感交流和心理沟通, 患者常产生被抛弃感, 导致性格、行为的改变, 表现为偏执, 自尊心强、沉默寡言。②恐惧和焦虑: 由于老年人

的各种机能下降, 脑卒中急危重症可给患者造成巨大的心理压力, 在重症监护室甚至产生濒死的恐惧心理, 加上住院后在饮食、休息、睡眠等各方面难以适应, 日常生活规律被打乱, 加之身患疾病, 从而精神上产生恐惧和焦虑。此类患者多表现为烦躁不安、痛苦呻吟、睡眠不佳、不思饮食, 过度关心治愈时间及预后。③敏感和猜疑: 老年患者常敏感多疑, 推测猜想自己的病情严重, 又怀疑医生、护士, 甚至家人都在对他有意隐瞒病情, 周围一个细小的动作、一句无意的话语, 都可能引起他的猜疑。④悲观和消极: 老年人因心、脑及其他器官功能衰退和功能下降, 常常会感到力不从心和老而无用, 由于病情反复、治疗效果不明显, 从而产生悲观与自责, 多表现为意志消沉、精神忧郁、束手无策, 常暗自伤心落泪, 不愿与人交往或交谈, 对治疗及疾病的转归表现漠然, 不愿接受治疗和护理, 消极地等待着“最后的归宿”。

5.4.2 高龄患者的心理康复: 为了促进高龄患者的身心健康, 康复治疗师不仅要了解患者的心理, 而且要对患者心理状态做出正确诊断, 针对患者个体差异及疾病阶段所表现的不同心理综合应用相应措施, 实施有效的心理治疗。(1) 建立良好的治疗关系: 良好的治疗关系是取得医患相互信任、开展心理康复的前提条件。越来越多的患者希望得到康复治疗师的帮助, 康复治疗师的温暖体贴、幽默又可对患者产生积极的影响。首先, 治疗师要耐心倾听患者诉说, 在倾听、解释和建议的基础上与患者形成治疗联盟, 彼此尊重、相互合作。其次, 康复治疗师应给予患者精神上的支持, 鼓励患者, 加强其战胜疾病的勇气和生活的信心, 让他们感受到生存的意义和目标。列举成功康复的例子鼓励患者, 对已经努力康复仍留有严重残疾者, 鼓励其康复, 不要有自身价值低下的想法。(2) 家庭和社会的支持: 1) 家庭支持: 家庭是老年人活动的主要场所, 和睦的家庭气氛、融洽的家庭关系是消除老年人孤独、寂寞感, 使他们感到幸福快乐, 并拥有良好情绪的重要保证。①营造融洽代际关系: 家庭中两代人或隔代人之间的关系称代际关系, 家庭成员之间应相互理解、相互尊重、加强沟通、和睦相处, 营造一个温馨、融洽的家庭氛围。②调节老年夫妻关系: 老年夫妻应相互尊重和理解、相互照顾和关心, 遇到矛盾时学会在“冷处理”原则的基础上妥善协调夫妻关系, 携手走完人生征程。2) 社会支持: ①加强人际交流: 避免孤独和寂寞; 疾病后重新调整和建立新的社会、家庭角色, 培养新的兴趣、爱好, 积极参与社会活动。②健全社会支持和保障体系: 健全的社会保障系统可以为老年人提供经济和医疗康复保证, 激发老年人参与社会活动的积极性, 从而对老年人的心理健康起到积极作用。(3) 心理支持疗法: 1) 认知疗法: 认知治疗就是通过纠正患者对疾病和康复治疗的错误认识, 在重建正确合理认识的基础上, 改善患者不良情绪和不当行为的方法。如卒中患者讲在焦虑时最担心自己瘫痪、做不了事, 给家庭造成负担, 心慌意乱, 引导患者改变思维方式, 让患者认识哪些是不合适的想法, 减轻思想负担, 积极主动参与康复治疗。2) 行为疗法: ①适应老年生活: 适应是个体对自己的行为进行自我调节和控制, 以保证与所处环境一致的过程。老

年人应自觉接受已发生脑卒中这一事实,做好心态调整,合理安排饮食和起居,适当体育锻炼,正确对待疾病,主动排解自己的不良情绪,勇敢面对现实,热爱生活,以乐观的态度度过每一天。②纠正不良行为:个人的生活方式是影响机体身心健康的重要因素。许多老年常见病、多发病均与不良的生活方式和行为有关。因此,老年人应注意纠正不良的行为方式,培养良好的生活习惯。③行为干预技术:帮助患者解决自己完成不了的生活问题,应用家庭作业训练患者新的社交技巧,与他人建立交往,帮助患者建立自尊心和自立感。(4)药物治疗法:在老年病的心理康复过程中应开展基础疾病的治疗,缓解症状,预防并发症;对于合并有情感障碍、神经症和精神症状的患者,可适当使用镇静剂、抗抑郁/焦虑药物及抗精神病药物治疗。(5)康复音乐治疗:康复音乐治疗(Rehabilitation Music Therapy, RMT)是康复治疗的方式之一,音乐治疗师运用一切与音乐有关的活动形式(如聆听、欣赏、演唱、合唱、器乐演奏、音乐创作、歌词创作、即兴演奏、舞蹈律动、美术等),增进伤病者的功能,使其功能恢复至伤病前水平的方法。音乐治疗的过程包括三个关键因素:音乐(活动),被治疗者,经过专门训练的音乐治疗师。音乐的不同呈现形式(如歌曲、器乐曲)、不同的表现形式(如录制音乐、现场演奏音乐等)都可以作为治疗手段对脑血管病患者的语言、认知、运动、社会情感等方面进行干预治疗,从而帮助他们进行功能性康复。

5.5 中医传统康复治疗以中医为代表,在东方发展的康复医学理念和技术(运动、意念、手法、针灸等)与西方发展的医学体系一起,构成了现代康复医学。中医学的核心理念先于现代医学,并已经成为现代医学所采纳的核心思想。天人合一、阴阳平衡、辨证施治、固本培元等思想已被现代医学界肯定,特别是“上工治未病,中工治欲病,下工治已病”的理念,与康复三级预防的思想异曲同工。以中医学为核心的东方康复医学认为人与自然、人与社会是辨证统一体,人体自身也是一个统一的整体,形神是相互影响的两个方面,强调基本康复应当考虑人体自身、人与自然、人与社会的综合因素,强调全面康复;在治疗上重视调动机体的自我修复能力,使之自然恢复健康。整体康复与辨证康复的思想,内治与外治相结合的综合康复措施,治未病、“杂合以治”及“养”“治”结合的理念,是中国康复医学的特色,也是优势。

中医康复学在治疗原则上既不同于现代康复学,也与中医临床学有区别,是在中医学基本理论指导下,针对残疾者、老年病、慢性病及急性病后期患者,通过应用各种中医药特有的养生康复方法及其他措施如针灸、推拿、传统体育、药物、药膳等,将这些技术综合起来,发挥各自优势,可取得更好的疗效,以减轻功能障碍带来的影响并使患者重返社会的医学科学。其中功能康复是中医康复医学的立足点。

现代康复学无论在理论还是治疗技术方面,均取得了长足的进步,尤其是中风病(脑卒中)的康复,形成了早期康复的理念和技术,使中风病康复的效果得到了极大提高,但是仍有诸多难题如运动康复中的疲劳和认知障碍对运动康复的影响以及痉挛、肩痛、感染、深静脉血栓形成等并发症。因此中

医学的切入对于中风病康复理念的拓展和康复效果的提高是一个必然选择。实践中也发现,中西医结合、内治与外治法相结合的综合康复治疗大大提高了中风病康复的效果,改善了中风患者的生活质量。对老年中风患者通过养生康复的各种方法来扶助人体正气,调动正气的自我修复能力,让机体的形神功能得到自然恢复。尤其是在社区,有效的中医适宜技术具有简、便、廉、验的优势,对于肌力、疼痛、平衡功能、认知功能等功能障碍具有确切疗效,已普遍用于康复临床,并发挥着重要作用。

脑卒中中医称为“中风”,分为中脏腑、中经络两类。目前中医治疗老年中风主要的方法为中药、针灸、推拿、食疗及传统训练疗法。

5.5.1 中药:在中医辨证的基础上运用中药,对高龄老人患者整体体质恢复有较大益处。①风中经络:辨证要点:半身不遂或但臂不遂,或口眼歪斜,肌肤不仁,发热恶寒,舌质淡红,舌苔薄白,脉弦细。治法:祛风通络。方药:小续命汤,组成:肉桂、麻黄、防风、防己、人参、黄芩、甘草、当归、川芎、杏仁、炮附子、生姜。②腑气不通:辨证要点:半身不遂或者肩臂不遂,或口眼歪斜,有脘腹闷满,大便秘结,小便黄赤,或见头晕烦躁,舌红苔黄或腻,脉弦或滑。治法:泻下通腑。方药:三化汤,组成:大黄、枳实、厚朴、羌活。③气虚痰阻:辨证要点:半身不遂或者但臂不遂,或口眼歪斜,痰多,面色萎黄,四肢倦怠,或见头眩,舌质淡有齿痕,舌苔白滑或白腻,脉滑或弦而无力。治法:益气豁痰通络。方药:二陈汤加减,组成:竹沥、胆南星、半夏、陈皮、茯苓、炙甘草。④气虚血瘀:辨证要点:肢体缓纵无力或见疼痛,舌质暗有瘀斑,或舌有齿痕,舌苔薄白,脉沉细或虚涩。治法:益气活血通络。方药:补阳还五汤,组成:赤芍、当归、川芎、桃仁、红花、地龙、生黄芪。⑤气滞经络:辨证要点:半身不遂或口眼歪斜,胁肋胀痛,善太息,脘腹满闷,得矢气稍快,舌质淡红,舌苔薄白,脉弦而有力。治法:行气活络。方药:八味顺气散,组成:人参、白术、茯苓、甘草、白芷、乌药、青皮、陈皮。⑥热邪壅盛:辨证要点:半身不遂,或但臂不遂,或口眼歪斜,颜面潮红,口渴喜冷饮,或见发热,小便黄赤,舌红苔黄,脉数有力。治法:泄热通络。方药:凉膈散,组成:生大黄、芒硝、栀子、薄荷、黄芩、连翘、竹叶。⑦气血两虚:辨证要点:肢体缓纵无力或苍白肿胀,面色淡白无华,少气懒言,声低气怯,爪甲焦脆不华,舌质淡有齿痕,脉细弱。治法:补益气血。方药:八珍汤,组成:党参、白术、茯苓、甘草、熟地、川芎、当归、白芍。⑧肾阴虚:辨证要点:肢体缓纵无力或见挛蜷,潮热盗汗,手足心热,头晕耳鸣,腰膝酸痛,咽干口燥,舌红少苔,脉细数。治法:滋补肾阴。方药:六味地黄丸,组成:熟地、山萸肉、山药、泽泻、茯苓、丹皮。⑨肾阳虚:辨证要点:肢体缓纵不收或见苍白肿胀,面色白,形寒畏冷,手足不温,或二便失禁或癃闭,舌质淡,有齿痕,舌苔薄白或白滑,脉沉迟无力,两尺弱。治法:温补肾阳。方药:八味地黄汤,组成:六味地黄汤加肉桂、炮附子(久煎)。⑩肝风挟痰:辨证要点:半身不遂或但臂不遂,或口眼歪斜,头晕或头痛,或舌强语,或急躁易怒,或见多痰,或肢体麻木,舌苔白腻,脉滑或弦。治法:熄

风祛痰通络。方药:镇肝熄风汤加味,组成:怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、白芍、玄参、天冬、生甘草、川楝子、生麦芽、青蒿、竹沥、胆南星。⑪肝肾亏虚:辨证要点:肢体缓纵无力,甚则肌肉萎缩,头晕目眩,失眠健忘,耳鸣耳聋,两目昏花,爪甲枯脆,毛发易脱不华,舌红少苔脉细数。治法:滋补肝肾。方药:地黄饮子加味,组成:生地、巴戟天、山萸肉、石斛、五味子、肉桂、茯苓、麦冬、石菖蒲、远志、生姜、大枣、薄荷,加女贞子、枸杞子。

5.5.2 针灸治疗:高龄脑卒中老人中风根据中医辨证,针灸总以补肾通阳、行气通络、醒脑开窍为主。①主穴:以督脉、背俞穴为主。双侧太溪、三阴交、足三里、肾俞、合谷、太冲、风池;水沟、大椎、命门、至阳。有中脏腑脱证者,以回阳固脱为主,以任脉为主,重用灸法。穴取关元、气海、神阙。②配穴:根据症状和辨证加减穴。促醒加用人中、百会、四神聪、十二经井穴,可用强刺激手法。意识恢复后治瘫痪加用解溪、太冲、丘墟、阳陵泉、脾关、迈步穴、极泉、外关、曲池、肩髃、偏瘫侧井穴、头针运动区。缓解肌张力加用头针震颤麻痹区、华佗夹脊穴。上肢屈肌痉挛取天井、清冷渊、消泅、臑会、中渚、外关、支沟、腕、指屈曲取合谷透劳宫、阳池、中渚,上肢伸肌痉挛取曲泽、郄门、间使、内关。下肢伸肌痉挛取殷门、委中、委阳、合阳、承山、承筋,下肢屈肌痉挛取伏兔、阴市、梁丘、丰隆、上巨虚,亦可用毫火针刺刺痉挛的患侧,毫火针放置在点燃的酒精灯上,从针体向针尖烧至通红,然后迅速刺入相应穴位,并迅速拔出,深度视穴位而定约 5~10mm。治失语或呛水、呛食加用廉泉(鸡爪刺)、完骨、翳风、风池、风府、哑门、头皮针的言语二区;促进食加用上巨虚、下巨虚、足三里。失明或偏盲加用睛明、球后、阳白、承泣、风池。精神症状或癫痫发作取百会、人中、内关,强刺激,如效果不佳,可加劳宫、涌泉。治面瘫加用颊车透地仓、颧髎透地仓、攒竹透精明、丝竹空透瞳子髎、太阳透下关。治二便潴留或失禁加用中极、水道、大赫穴、天枢、大横、次髎、大肠俞、膀胱俞、秩边。多汗取灸百会、关元、足三里。足下垂取丘墟、抬脚穴。足内翻取悬钟、丘墟、足临泣。肩-手综合征,早期取肩髃、肩髃、臂臑、曲池、外关、阳池、中渚、八邪等,用泻法,肿甚者可用三棱针点刺井穴或指尖放血;中后期及后遗症期上述诸穴取补法,可用温针灸,不可放血。头针取头三针、头针运动区;眼针疗法,治脑卒中偏瘫取上下焦区穴,可使患侧逐渐恢复自主运动。③说明:对于高龄脑卒中患者,以毫针为主,根据患者不同部位施用 $0.35 \times 25\text{mm}$ 、 $0.35 \times 50\text{mm}$ 、 $0.35 \times 70\text{mm}$ 的毫针。根据症状和辨证也可以加用电针治疗,电针参数:连续波,频率 30~100Hz,电流强度 1~5mA,逐渐增大电流强度以患者耐受为度。针刺每天或每 2 天治疗 1 次,连续治疗 5 次后,休息 2 天再进行下一次治疗,按病情轻重和患者的适应能力设置治疗针刺疗程。

5.5.3 推拿:推拿对肢体萎缩肌肉的有一定的保护,并促进四肢肌力的恢复。操作步骤如下:①先用抚摩法,继以揉捏法,最后屈伸旋转被动运动,推拿要由轻到重,由小到大。病程短者,每次推拿 15~20 分钟,病程长者可延长至 45 分钟。②抚摩:用手指或手掌紧贴患肢,有节奏地按向心性方向在皮

肤表面回旋式向前进行摩动,力量要均匀,频率要慢。③揉捏:在患肢手指、手掌、前臂、小腿等部位用手指揉捏,即一手扶抚患肢,以另一手指握住患部,以拇指为前导向作旋转运动,同时其余手指在另一边向其相反方向旋转。④推拿:医者先用手指或手掌沿经络走行方向或瘫痪肌群方向向前推动,开始缓慢,逐渐加快,然后用手指拿患肢肌肉和经穴 2~3 次,并拿展卷曲的筋脉。

5.5.4 食疗:气虚血瘀者,用黄芪、山楂、粳米适量同煮粥;肝肾亏虚者取山药、龟板、瘦猪肉,煮熟服用;脾虚痰湿者取薏苡仁、白扁豆、山药、白萝卜、粳米煮粥服用。

5.5.5 传统训练疗法:老年脑卒中患者可结合疾病的不同时期,在专业人士的指导下进行,鼓励并发挥患者自身的主观能动性,让患者主动参与太极拳、八段锦、医疗气功等锻炼。常用的医疗气功功法、功法很多,但都以动静为纲,以三调为目。静养型以静养精气神为主,如放松功、内养功等,在脑卒中急性期及恢复期较为适合;恢复期和后遗症期以体操型为主,以锻炼筋骨皮肉为主,特点是通经活络,强筋健骨,如从太极拳、易筋经、八段锦、推拿操等。根据患者具体情况,可以从个别动作开始,可以在跪位、座位、站立下,以外动促内动而求心静,特点是导引气血,扶正祛邪。如老子推拿法、自发功,是静极生动,运动内气催动肢体,其特点是内气运行,运动筋骨,壮元强身。患者病情稳定后,根据个人情况和习惯,建议做一些按导摄生术、园艺、散步、中药熏蒸、水中行走等。注意事项:高龄脑卒中患者在康复训练中的主要危险因素有脑血管意外复发、心血管并发症、跌倒致软组织损伤或骨折、继发肺栓塞、手法不当引起肩关节半脱位等,在康复中要予以监护和防范。同时要高龄患者保持平稳的情绪,训练过程中要适当休息,避免过度疲劳。

5.6 其他治疗

5.6.1 高龄中风患者的吞咽障碍康复:吞咽障碍是指由于下颌、双唇、舌、软腭、咽喉、食管等器官结构和(或)功能受损,不能安全有效地把食物输送到胃内的过程。吞咽障碍常常会引起误吸、吸入性肺炎,严重时甚至引起窒息、死亡等严重后果,而且因经口进食量的减少,导致脱水、电解质紊乱及营养不良,显著增加卒中患者的病死率,严重影响卒中患者生活质量,对家庭和社会造成了严重负担。(1)引起高龄中风患者吞咽障碍的原因:①生理上的变化。②认知能力衰退。③高龄患者味觉、嗅觉功能减退,牙齿缺失、口腔敏感性减退、视力减退、目光注视与手的协调动作减退、独自进食、情绪抑郁等都可引起食欲减退及不同程度的吞咽障碍。④姿势的变化。⑤高龄患者的舌腭等长收缩运动的持续能力减退,加之环境变化及药物的副作用,可能会引起唾液分泌减少,影响咀嚼和食团的形成。⑥口腔及咽喉的感知能力减退会导致吞咽后延迟,增加误吸的风险。而且高龄中风患者食管蠕动减慢,胃排空能力下降,食道下括约肌静息压下降,胃食管返流的机会增多,也是引起误吸的重要原因之一。(2)高龄中风患者吞咽障碍的康复治疗:高龄中风患者吞咽康复的手段包括:口腔感觉训练、口腔运动训练、气道保护方法、低频电刺激、表面肌

电生物反馈训练、球囊扩张术、针刺治疗、神经调控技术、代偿性手段等。(3) 高龄中风患者吞咽障碍患者康复过程中的注意事项: ①误吸的预防: 误吸是指将口咽部内容物或胃内容物吸入声门以下呼吸道的现象。误吸是吞咽障碍最常见的并发症。食物残渣、口腔分泌物等误吸至气管和肺,引起反复肺部混合性感染,严重者甚至出现窒息而危及生命。高龄患者呼吸道防御能力降低,咳嗽力量减弱。老年人晚上睡觉时经常采用仰卧位,口腔、咽腔内的分泌物和胃食道返流的胃液常会误吸至肺部造成肺炎。临床医师应根据肺炎的严重程度以及出现误吸的情况来决定治疗方案。首先选择药物性治疗,其次要注意纠正脱水与电解质紊乱。另外,口腔清洁、调整食物形态,进食姿势及加强呼吸功能训练等都是减少误吸的重要措施。②营养不良: 卒中后吞咽障碍是营养不良的独立危险因素,卒中后营养不良的发生率为 6.1% ~ 6.2%。卒中后营养不良的原因有多种,包括高龄、机体高分解状态,脑干、下丘脑功能紊乱所致神经内分泌和胃肠动力异常等均是卒中患者发生营养不良风险的重要原因。在补充营养时,除了要补充水分、电解质之外,还要确定所需的热量,其中首先要确定蛋白质的需要量,之后再以碳水化合物和脂肪补充不足的热量。③窒息: 在高龄患者的意外死亡原因中,窒息是第一位的。进食原本是快乐的过程,却变成致命的危险因素。最容易造成窒息的食物是麻薯、果冻,其他如米饭、面包、甜点、肉类、水果等日常食品也可造成窒息。此外,老年人呼吸功能的下降,痰液难以咳出,也是导致窒息的重要原因之一。

5.6.2 高龄中风患者的认知障碍康复: 脑卒中后认知障碍 (post stroke cognitive impairment, PSCI) 是脑卒中后常见的并发症之一,近些年在神经内科和康复科得到重视,其主要临床表现为注意力、记忆力和执行力障碍以及失语、失认、失用、视空间障碍等。PSCI 后患者不能主动参与到康复训练中,严重影响着患者的功能预后。目前常用的评定方法有: 简易精神状态量表 (MMSE)、蒙特利尔评定量表 (MoCA)、成套测试法 (LOTCA)、功能检查法 (FIM)、计算机测评、脑功能成像、电生理、事件相关电位等。常用的康复治疗方法有认知功能训练、认知运动疗法、电脑辅助认知训练、作业治疗、心理治疗、重复经颅磁刺激 (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)、经颅直流电治疗、针刺疗法、娱乐疗法、音乐疗法、高压氧治疗等。目前临床最常用的重复经颅磁刺激改善卒中后认知效果显著,其机制主要可能是: ①增加脑血流和调节离子平衡; ②调节神经环路; ③调节神经递质释放; ④调节突触可塑性; ⑤免疫炎症; ⑥抗细胞程序性死亡。

6. 高龄脑卒中患者康复风险事件预防与处理

6.1 高龄脑卒中患者康复风险事件预防 风险事件的预防是对患者发病前可能产生伤害的潜在风险进行识别,评估并采取正确行动或预防措施的过程。在脑卒中患者康复过程中实行风险事件预防,避免潜在并发症的发生,能够有效促进康复治疗,减少不必要危险因素的发生,为后期的康复治疗提供一个良好的治疗环境,有助于高龄脑卒中患者回归社会和生活。

6.1.1 高度重视康复安全: 医生要详细了解患者的病情,在

以安全为前提的同时,做出具有针对性的康复治疗方案,对患者做必要的身体素质评估,准确把握适应证和禁忌证,为高龄患者安排适当强度的康复训练。

6.1.2 保证患者及家属的知情同意权: 为防止意外事件的发生,应与患者或家属进行有效的沟通,把康复过程中潜在的风险告知患者及家属,任何康复训练项目在征得患者或家属同意后并签署知情同意书后方可实施。

6.1.3 加强康复风险意识,积极控制原发疾病: 医生应多询问,多观察,多思考,考虑到患者所做康复项目具有的潜在风险,家属也要配合医生注意康复风险先兆。严格控制高血压、糖尿病等原发疾病的治疗,避免影响康复效果,降低脑卒中的复发。

6.1.4 严格遵循康复规范: 康复治疗师准确的操作治疗仪器,在治疗过程中与患者多交流,并根据患者的情况调整康复治疗方

案。6.1.5 建立多学科的综合治疗: 通过连贯的多学科团队的建立和高效配合,有助于诊断的精确性和规范化治疗,能收到较好的预后,有效降低死亡率和致残率,把握最佳治疗时间,使治疗更具整体性、时效性和稳定性,增加患者及家属的安全感。

6.1.6 配置急救设备: 配备急救设备,以备不时之需,风险发生后,积极应对,熟练掌握急救技能。

6.2 风险事件处理流程 高龄脑卒中患者在康复过程中易发生的风险包括跌倒风险、骨、关节、肌肉、韧带损伤的风险,感染风险等,当康复风险事件发生后,应积极应对,具体处理流程如下:

6.2.1 风险评估: 根据患者的病情 (肌力分级、患侧活动功能、吞咽功能等)、影响风险发生的因素、机体营养状况、潜在或并发疾病,初步判断患者可能发生的风险,制定风险评估表。

6.2.2 风险事件或问题的判断: 通过风险评估结果,判断患者发生风险的确切因素,为风险事件的处理提供依据。

6.2.3 风险事件处理计划: 针对具体的风险事件,作出相应的处理。例如: 定期翻身,保持受压部位干燥和清洁,主动和被动运动,避免卒中后挛缩和感染等并发症的发生,引起压疮; 对老年脑卒中患者进行筛查,针对吞咽障碍的不同程度实施不同的训练方案,预防吸入性肺炎的发生,避免卒中进展; 评估患者深静脉血栓风险; 提高高龄脑卒中患者日常生活活动能力和生活质量,减少卒中后运动障碍伴随的跌倒风险; 脑卒中的二次复发具有更高的致残和致死风险,所以发现并及时防治糖尿病、高血压、高血脂等危险因素至关重要。

6.2.4 个体化健康教育: 风险事件处理完成后,对患者或家属进行个体化健康教育,告知患者或家属注意事项,避免不良情绪的产生以及风险事件的再次发生。

7. 高龄脑卒中患者康复质量管理

7.1 建立高龄脑卒中患者康复医疗档案需要各级医疗单位 (包括社区医院、二级医院、三级医院等) 与信息产业化相结合,形成多层采集、多层筛选、大数据汇集,逐步建立和完善相

应人群的康复医疗档案。通过社区、各级医院数据采集,移动社区筛查,解决了高龄脑卒中患者数据采集的问题,打通了数据渠道采用身份证读卡器等设备解决了人员身份信息的快速识别和采集。通过移动社区筛选系统可以高效完成筛查工作。同时,采用数据快速录入,如筛查工作站设备,可以实现任意组网使用移动设备快速加入网络,方便工作人员的数据录入与查询。最终实现精准引导患者到医院就医,建立高龄脑卒中患者康复医疗档案,甚至区域人群健康档案,建立院前医疗服务机制。

7.2 质量控制管理体系建立的基础是康复医疗档案和医疗数据库的建立。完善院内的脑卒中患者医疗数据库,通过数据质量控制和数据的指控机制,替代传统的人工录入数据的方式,提升了数据质量。采用分病种分学科的康复治疗方式,划分 PT、OT、ST、水疗等康复内容,并根据病种进行不同的康复路径。康复医疗系统协调各个角色间的工作,完成康复日常工作的管理。通过搭建本区域内的卒中数据中心,实现联盟医院数据与区域数据中心的数据汇总。脑防委与中国卒中联盟等多平台对接,响应国家的发展战略及上级单位的任务要求,实现院内卒中数据库与上级单位平台的对接。引入卒中单元多学科诊治模式和卒中单元的管理模式,使治疗、康复、营养等多学科联合为患者诊治。

7.3 对每一个高龄脑卒中患者进行评估与监督体系的建立和完善是未来所有大数据的来源。通过引入大量国际化标准量表,对每一个高龄脑卒中患者进行系统评价,对院内和区域内卒中患者的医疗数据进行分析。系统设置不同层级医师、治疗师、护士界面,有自上而下监督、管理的权限,并分设责任区间,每个工作人员要对自己的评估结果和治疗负责。

7.4 康复相关规范化培训课程完善脑卒中患者及家属的健康教育培训演示模块,包含大量演示文件、文字、图片、动画等多种格式文件。这些文件涉及卒中学习、临床指导、健康教育、病理病因、理论知识等,在一定程度上对临床工作者增长业务水平、提高技能和交流经验起到了推动作用,同时为医患互动交流提供平台。

7.5 疗效评估与阶段总结针对每个患者制定个性化康复计划,并跟踪和管理,查看计划执行效果。根据患者的治疗计划和评估自动生成康复报告,在患者康复数据平台上对康复数据分析和挖掘。

7.6 患者满意度调查根据出院日期,定期与患者或家属联系采集数据,实现了数据的连续性。建立随访系统,内置随访工作的标准化流程和患者满意度调查体系,信息化指导和评估日常的工作,系统自动对随访工作人员数量和质量进行统计,可以维护好患者与医院的长期关系。

8. 日常生活能力指导

8.1 日常活动指导日常生活活动分为基本的日常生活活动(basic ADL, BADL)和复杂性或工具性 ADL(instrumental ADL, IADL)。日常生活活动训练主要内容有自我照顾训练,穿衣、修饰、进食、大小便管理和洗澡等;转移活动训练,床上翻身、卧-坐转移、床-椅转移、坐-站转移、步行、上下楼梯

等,具体指导和训练方法如下。

8.1.1 个人卫生:鼓励患者用单手进行。如利用健侧手洗脸,可将毛巾绕在水龙头上,用健手将其拧干;洗澡时,通常采取淋浴式,患者可坐在椅子上或轮椅上,洗澡的方法可用健侧手持毛巾或用长柄的海绵刷擦后背。

8.1.2 穿、脱衣裤:衣服要宽松,裤子最好为松紧带式,鞋为搭扣式。穿上衣时,先穿患侧,再穿健侧,脱衣时相反;穿裤子时,取叉开腿坐位,先穿患腿,再穿健腿,然后躺下用健腿支撑臀部将裤子拉上。脱裤时与上面动作相反。穿、脱袜子和鞋时,将健侧下肢放在患侧下肢上方穿好健侧袜子或鞋。

8.1.3 转移:(1)床上转移包括:床上左右移动和床上翻身,患者在床上移动时必须有人保护,注意保护患肩。(2)床-椅子、轮椅转移:把椅子或轮椅放在健侧床边,与床成 45° 角,患者坐在床边,用健手扶住外侧椅子或轮椅扶手,站起后旋转身体坐下,保证患者坐轮椅的姿势正确,身体尽量向后靠,以保持稳定性。(3)轮椅-椅子:常用侧方转移法,轮椅和椅子健侧面成 60° 角,卸下轮椅健侧面扶手,进行转移,轮椅与马桶之间转移常用此方法。(4)坐-站转移:患者坐于床边或椅子上,躯干挺直,双足踩于地面,应注意将患足置后,降低躯干向健侧的偏移程度,髋关节屈曲,躯干前倾,重心向双腿移动,重心继续转移至足前掌部,站立。在转移过程中需要保护,要防止意外发生。注意:以上转移时,要拉好轮椅手刹,保证轮椅处于固定状态,以保证患者安全,避免患者的二次损伤。(5)步行和上下楼梯:①步行:患者应具备站立和平衡的基础,采用三点步行法在平行杠内行走,健侧手→患侧下肢→健侧下肢,嘱患者骨盆自然放松,患侧下肢屈髋、屈膝、踝背屈,也可使用助行器或手杖行走。②上下楼梯:患者在上楼梯时,患者健手扶持扶手,重心转移至健腿,患侧腿先迈上台阶,重心转移至患侧腿再迈健侧腿;下楼梯时健手扶持扶手,重心转移至患侧腿,健侧腿先向下,再患侧腿向下,以保证患者安全。

8.2 睡眠指导睡眠障碍是脑卒中后的严重并发症,可表现为失眠、嗜睡、睡眠呼吸障碍,发作性睡病和夜间入睡后常伴有精神症状,如自语、不自主摸索动作、兴奋躁动、情绪欣快或愤怒发作、强哭等精神症状。脑卒中后发生阻塞性睡眠呼吸暂停的危险性增加,使患者的生活质量下降,神经功能修复受阻,脑卒中复发的风险增加。

8.2.1 脑卒中后睡眠障碍的典型表现:①失眠:是指睡眠的质和量都出现问题,即入睡困难、睡眠维持困难,并引起白天不适(无力、疲劳、精神不集中、情绪不稳定、易怒)。②过度睡眠:睡眠时间延长,睡眠过多或深睡过多,表现为夜间睡眠时间延长或日间睡眠增多。③睡眠周期紊乱:脑血管病患者可出现如同婴儿期的多相睡眠,或睡眠颠倒。④异相睡眠:指在睡眠中出现的各种异常现象,如梦魇、梦呓、夜惊、睡眠中周期性动作等。

8.2.2 睡眠障碍的治疗:(1)药物治疗:①对于失眠或睡眠中出现异常现象的患者可用镇静催眠药物,如苯二氮卓类及吡咯酮类,但此类药物有副作用大和长期不间断的缺点。②对于伴有情绪障碍的患者应给予抗抑郁、抗焦虑药物治疗。

③对于过度睡眠者可给予兴奋中枢神经系统的药物,常用的药物主要有苯丙胺类兴奋剂等。④我国特有的中药、针灸等治疗对一些患者也有一定的帮助。(2) 心理治疗:良好的心理疏导治疗能使患者正确认识疾病,唤起积极情绪,与药物治疗配合可取得更好的效果。(3) 神经调控治疗:经颅磁刺激、经颅直流电刺激以及多参数生物反馈的神经调控作用在睡眠障碍方面均有较好疗效。(4) 保持良好的情绪:中风后患者会产生一系列精神心理变化,如对生活失去信心、忧郁,甚至产生轻生的念头。患者要有意识地多与人交往、谈心,树立战胜疾病的信心,积极参加娱乐活动,做一些力所能及的家务也有助于治疗和康复。

8.3 饮食指导 2016 年中国老年居民膳食指南指出 食物多样,谷类为主,粗细搭配;多吃蔬菜水果和薯类;每天吃奶类、大豆或其制品;常吃适量的鱼、禽、蛋和瘦肉;减少烹调油用量,吃清淡少盐膳食;食不过量,天天运动,保持健康体重;三餐分配要合理,零食要适当;每天足量饮水,合理选择饮料;饮酒适量;吃新鲜卫生的食物;食物要粗细搭配,松软,易于消化吸收;合理安排饮食,提高生活质量;重视预防营养不良和贫血。高龄中风患者多有高血压、血脂紊乱或高血糖等病史,合理安排饮食有助于控制原发病,使机体保持相对平衡的状态,也是保证正常睡眠的重要条件。每日食物分配,以早、中餐为主,晚餐量宜少。每天摄取总热量为 1500 ~ 2000 千卡,盐的摄入量每人每日不宜超过 6g。适当食用瘦肉、鱼、豆制品、蛋清以及禽肉等含胆固醇较低的食物,食用植物油,忌食含胆固醇高的食物,如蛋黄、牛油、猪油等动物脂肪。多吃芹菜、油菜等纤维多的蔬菜,以刺激肠蠕动,防止便秘。

8.4 老年脑卒中健康教育脑卒中不仅对患者造成不同程度的躯体功能障碍、语言障碍、吞咽障碍,还会导致患者出现种种心理障碍,严重影响患者的生活质量,因此及时对患者及家属给予适当合理的健康教育,对于减少脑卒中的并发症,提高患者治疗疾病的信心,提高老年脑卒中患者回归社会后的生活质量就显得越来越重要。

8.4.1 老年脑卒中患者健康教育的特点:由于大部分老年患者对疾病相关知识缺乏,理解力、记忆力较差,接受能力和适应能力也差,患病以后生活环境的改变造成不同程度的心理焦虑,影响教育效果,因此要对老年患者或家属进行反复多次沟通。还可以利用每次治疗护理机会对健康宣教的内容进行评价,对部分患者掌握不好的内容采取复述和演示的方法巩固教育效果;发放健康教育手册供患者阅读,加深印象,并能长期保存;也可采用提问的方式帮助患者记忆。每天评价前日的教育效果,让老年患者复述能增强教育效果,随时调整健康教育对策。

8.4.2 健康教育的内容:发病后期预防是指对已患脑卒中的患者,借助各种临床治疗方法,促进患者早日康复,降低致残率,提高患者的生活质量。可根据病程为患者分阶段进行健康教育,健康宣教的内容应由浅入深、循序渐进。如对脑卒中急性期患者要首先讲卧床休息、良肢位摆放、保持大小便通畅、翻身叩背、减少探视的重要性;病情稳定后再讲疾病的病

因、发展、转归,以及尽早主被动活动的意义;恢复期将功能锻炼、理解能力的训练作为重点;出院前重点讲述脑卒中的防治及出院后的注意事项,这样的教育内容不易遗漏,便于老年患者接受、记忆。

9. 展望

随着国民经济及医疗卫生事业的发展,人们健康水平不断提高,人均寿命也得到了延长。国家统计局最新发布的数据,2016 年我国 60 周岁及以上人口 23086 万人,占总人口的 16.7%;65 周岁及以上人口 15003 万人,占总人口的 10.8%。据 1992 年中国老龄科研中心调查资料显示:老年人中全部或部分丧失生活自理能力的约为 6%,并随年龄的增长所占比重呈规律性上升,85 岁以上老人中有 40% ~ 50% 不能独自出门活动。高龄老人由于其自身基础疾病多、多脏器功能不全等因素,高龄脑卒中患者的病死率、致残率都相对较高。本专家共识针对高龄脑卒中患者的特点,对其康复治疗的特点进行了详细阐述,尤其在患者的日常生活能力、心理、康复风险评估及康复质量管理等方面,这些平时容易忽视的地方也都进行了较多篇幅的阐述。高龄老年人群本身就是一个高危人群,而高龄脑卒中患者如何有质量的生存,是需要重点关注的地方。以往我们更多关注患者的预期寿命,现在应该将患者的生活质量放在首位,对于高龄脑卒中患者如何有尊严的生活应该得到国家、社会和家庭的更多支持和关注。

编写专家组成员(单位):

组长:武亮(北京小汤山康复医院)

副组长:董继革(中国中医科学院望京医院)、黄力平(天津体育学院)、宋桂芹(国家电网公司北京电力医院)、宋鲁平(中国康复研究中心北京博爱医院)、谢瑛(首都医科大学附属北京友谊医院)、张玉梅(首都医科大学附属北京天坛医院)

学术秘书:谷磊(北京小汤山康复医院)、罗玲玉(北京小汤山康复医院)、肖娟(北京小汤山康复医院)

编写专家(以下按姓氏拼音首字母为序):程先宽(中国康复研究中心北京博爱医院)、丛芳(中国康复研究中心北京博爱医院)、陈雪丽(北京老年医院)、邓景元(西安交通大学医学院第一附属医院)、方伯言(首都医科大学附属北京康复医院)、高新(广西壮族自治区人民医院)、侯来永(中日友好医院)、韩兴成(青海省康复医院)、矫玮(北京体育大学)、罗丽华(中国中医科学院望京医院)、栾霞(山东省青岛疗养院)、李玉明(北京医院)、李强(天津市宁河区医院)、刘松怀(中国康复研究中心北京博爱医院)、李瑞杰(北京市第一中西医结合医院)、刘建华(中国康复研究中心北京博爱医院)、李巧林(广东省干部疗养院)、马将(石家庄市第一医院)、那涛(深圳市光明新区人民医院)、乔晋琳(中国人民解放军总医院)、宋振华(中南大学湘雅医学院附属海口医院)、单述刚(山东省青岛疗养院)、孙岚(中国康复研究中心北京博爱医院)、滕秀英(黑龙江中医药大学附属第二医院)、谭同才(浙江省人民医院)、卫冬洁(中国康复研究中心北京博爱医院)、许梦雅(郑州大学第二附属医院)、徐俊峰(中国康复研究中

心北京博爱医院)、徐晖(北京大学第一医院)、赵建功(北京小汤山医院)、张艳明(首都医科大学宣武医院)、张晓颖(中国康复研究中心北京博爱医院)、张志杰(河南省康复医院)、张庆苏(中国康复研究中心北京博爱医院)。

参 考 文 献

- 徐岩. 高龄人群缺血性脑卒中危险因素分析 [J]. 社区医学杂志, 2011, 9(13): 58-59.
- Pastuszek Z, Koźniowska E, Stepień A, et al. Importance rating of risk factors of ischemic stroke in patients over 85 years old in the polish population [J]. Neurol Neurochir Pol, 2018, 52(1): 88-93.
- Turaj W, Słowik A, Szczudlik A. First ischemic stroke in the very old: Etiology, clinical course and outcome [J]. Prz Lek, 2003, 60(8): 512-515.
- Callaly EL, Ni Chroinin D, Hannon N, et al. Falls and fractures 2 years after acute stroke: the north dublin population stroke study [J]. Age Ageing, 2015, 44(5): 882-886.
- 中华医学会神经病学分会神经康复学组, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组, 卫生部脑卒中筛查与防治工程委员会办公室. 中国脑卒中康复治疗指南(2011 完全版) [J]. 中国医学前沿杂志(电子版), 2012, 4(6): 55-76.
- 中国脑梗死急性期康复专家共识组. 中国脑梗死急性期康复专家共识 [J]. 中华物理医学与康复杂志, 2016, 38(1): 1-6.
- Winsten CJ, Stein J, Arena R, et al. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: A guideline for healthcare professionals from the american heart Association/American stroke association [J]. Stroke, 2016, 47(6): e98-e169.
- Lee SH, Seo J, Lee JM, et al. Differences in early and late mild cognitive impairment tractography using a diffusion tensor MRI [J]. Neuroreport, 2014, 25(17): 1393-1398.
- Howe AS, Bani-Fatemi A, De Luca V. The clinical utility of the auditory P300 latency subcomponent event-related potential in preclinical diagnosis of patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease [J]. Brain Cogn, 2014, 86: 64-74.
- Frank B, Schlote A, Hasenbein U, et al. Prognosis and prognostic factors in ADL-dependent stroke patients during their first in-patient rehabilitation: A prospective multicentre study [J]. Disabil Rehabil, 2006, 28(21): 1311-1318.
- 张玉梅, 宋鲁平. 康复评定常用量表 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2018.
- Peri E, Ambrosini E, Pedrocchi A, et al. Can FES-augmented active cycling training improve locomotion in post-acute elderly stroke patients? [J]. Eur J Transl Myol, 2016, 26(3): 6063.
- Park Y, Chang M. Effects of the Otago exercise program on fall efficacy, activities of daily living and quality of life in elderly stroke patients [J]. J Phys Ther Sci, 2016, 28(1): 190-193.
- Podubecka J, Scheer S, Theilig S, et al. Cyclic movement training versus conventional physiotherapy for rehabilitation of hemiparetic gait after stroke: A pilot study [J]. Fortsch Neurol Psychiatr, 2011, 79(7): 411-418.
- Lo Coco D, Lopez G, Corrao S. Cognitive impairment and stroke in elderly patients [J]. Vasc Health Risk Manag, 2016, 12: 105-116.
- Pang MY, Charlesworth SA, Lau RW, et al. Using aerobic exercise to improve health outcomes and quality of life in stroke: Evidence-based exercise prescription recommendations [J]. Cerebrovasc Dis, 2013, 35(1): 7-22.
- Louie DR, Eng JJ. Powered robotic exoskeletons in post-stroke rehabilitation of gait: A scoping review [J]. J Neuroeng Rehabil, 2016, 13(1): 53.
- Langa KM, Levine DA. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: A clinical review [J]. JAMA, 2014, 312(23): 2551-2561.
- Schwartz JB. Primary prevention: do the very elderly require a different approach? [J]. Trends Cardiovasc Med, 2015, 25(3): 228-239.
- 克鲁逊, 南登. 克氏康复医学 [M]. 湖南科学技术出版社, 1990.
- 胡永善. 新编康复医学 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2005.
- 李小鹰. 老年医学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015.
- 王宁华, 黄真. 临床康复医学 [M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2006.
- SARA J. Cuccurullo, MD, 康复科医生进阶精要 [M]. 人民军医出版社, 2016: 157.
- 胡永善. 运动疗法应用研究进展 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2010.
- 胡军. 作业治疗学 [M]. 北京: 中国中医药出版社, 2017.
- 窦祖林. 作业治疗学 [M]. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2013.
- 贾建平, 陈生弟. 神经病学 [M]. 7 版. 北京: 人民卫生出版社, 2013.
- 励建安, 张通. 脑卒中康复治疗 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016.
- 王维治. 神经病学 [M]. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2013.
- 周郁秋, 张渝成. 康复心理学 [M]. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2014.
- 朱红华, 温优良. 康复心理学 [M]. 2 版. 上海: 复旦大学出版社有限公司, 2017.
- Kenneth E Bruscia. Definition of Music Therapy [M]. Second Edition. Barcelona Publishers, 1998: 198-199.
- 高天. 音乐治疗导论 [M]. 修订版. 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2008.
- M. H. Thaut, V. Hoemberg. Handbook of Neurological Music Therapy. Oxford. 2014.
- 窦祖林. 吞咽障碍评估与治疗 [M]. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2017.
- Bogaardt HC, Grolman W, Fokkens WJ. The use of biofeedback in the treatment of chronic dysphagia in stroke patients [J]. Folia Phoniatr Logop, 2009, 61(4): 200-205.
- 郭钢花, 宋垒垒, 李哲. 肌电生物反馈治疗慢性神经源性吞咽障碍的临床观察 [J]. 中国实用医刊, 2013, 40(11): 70-71.
- Foley NC, Martin RE, Salter KL, et al. A review of the relationship between dysphagia and malnutrition following stroke [J]. J Rehabil Med, 2009, 41(9): 707-713.
- Corrigan ML, Escuro AA, Celestin J, et al. Nutrition in the stroke patient [J]. Nutr Clin Pract, 2011, 26(3): 242-252.
- Perry RT, Collins JS, Wiener H, et al. The role of TNF and its receptors in Alzheimer's disease [J]. Neurobiol Aging, 2001, 22(6): 873-883.
- 周剑锋. 早期规范康复训练对高龄缺血性脑卒中偏瘫患者运动功能和日常生活能力的影响 [J]. 中国实用神经疾病杂志, 2015, 18(19): 58-60.
- Joshua AM, Karnad SD, Nayak A, et al. Effect of foot placements during sit to stand transition on timed up and go test in stroke subjects: A cross sectional study [J]. NeuroRehabilitation, 2017, 40(3): 355-362.

同伴教育利于老年全膝关节置换患者术后早期疼痛控制

郭军辉 赵 英 聂志强 韩海津

作者单位: 天津市海洋石油总医院 康复医学科 300452

基金项目: 国家自然科学基金(编号: 81601962)

【摘要】 目的 探讨同伴教育对老年全膝关节置换术后患者早期疼痛的影响。**方法** 人工膝关节置换 80 例,随机分为两组,观察组 40 例(平均年龄 62.92 ± 5.37 岁,男女比例 14 : 26),对照组 40 例(平均年龄 64.03 ± 5.37 岁,男女比例 12 : 28)。两组患者均给予加速康复外科理念干预,观察组康复过程中加入同伴教育,进行 2 周以上干预治疗。采用视觉模拟评分对患者术后第 1 天、2 天、3 天疼痛进行评估,采用 HSS 评分、膝关节活动范围、改良 Barthel 指数量表评估患者术前、术后第 1 天、术后 2 周膝关节活动度及日常生活能力;记录患者术后并发症发生率。**结果** 与对照组相比,术后 1 天、2 天、3 天疼痛视觉模拟评分显著降低,术后并发症,如深静脉血栓、便秘、肺部感染、泌尿系感染发生率降低,差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。**结论** 老年全膝关节置换患者康复训练中加入同伴教育利于术后早期疼痛控制,促进其早日回归家庭和社会。

【关键词】 同伴教育 加速康复外科 日常生活能力 人工膝关节置换

doi: 10.3969/j.issn.1672-2671.2019.01.002

Effect of peer education on early pain in elderly patients after total knee arthroplasty (GUO Junhui, ZHAO Ying, NIE Zhiqiang, HAN Haijin. Rehabilitation medicine department, Tianjin offshore oil general hospital, Tianjin 300452, China.)

【Abstract】 Objective To explore the effect of peer education on early pain in elderly patients after total knee arthroplasty.

Methods 80 cases of total knee arthroplasty were randomly divided into two groups, 40 cases in observation group (mean age 62.92 ± 5.37 , male: female 14 : 26), 40 cases in control group (mean age 64.03 ± 5.37 , male: female 12 : 28). Two groups of patients were given the concept of fast track surgery intervention, the observation group in the process of rehabilitation to join peer education. Patients in both groups were treated with 2-week intervention. Visual analogue scale was used to evaluate the pain on the first, second and third days after operation. HSS score, range of motion of knee joint and modified Barthel index scale were used to evaluate the Knee range of motion and activities of daily living of all patients before, 1 day and 2 weeks after operation. Recording the incidence of postoperative complications in patients. **Results** Compared with the control group, the pain visual analogue scores were significantly lower at 1 day, 2 days, and 3 days after surgery. The incidence of postoperative complications such as deep vein thrombosis, constipation, pulmonary infection, and urinary tract infection decreased, and the difference was statistically significant ($P < 0.05$).

Conclusion The addition of peer education in rehabilitation training for elderly patients with total knee arthroplasty is beneficial to early postoperative pain control, facilitate their early return to families and societies.

【Key words】 peer education, fast track surgery, activities of daily living, artificial knee arthroplasty.

骨性关节炎和类风湿性关节炎给人们的生活质量造成了严重影响。全膝关节置换(total knee arthroplasty, 全膝关节置换) 是目前治疗中重度骨关节炎的重要方法^[1], 其目的是达到纠正畸形、减轻疼痛、改善膝关节功能及患者日常生活能力, 提高生活质量。尽管全膝关节置换的手术量逐年上升, 术后疼痛及卧床后行动不便等因素会给患者带来巨大的恐惧和心理压力^[2], 进而造成术后早期锻炼不及时、不到位, 康复进

展缓慢, 功能恢复不良, 导致全膝关节置换术后满意度仍然低于髋关节置换^[3,4]。

多项研究显示加速康复外科(FTS) 可明显改善全膝关节置换术后患者 HSS 评分、关节活动度、疼痛及日常生活能力, 减少手术应激及术后并发症, 加速了患者康复, 改善了治疗效果^[5-7]。但目前国内存在康复治疗师严重不足, 按照国际标准来计算, 我国康复治疗师至少缺口 30 万^[8], 导致治疗师比

- 44 刘孟, 倪朝民, 陈进, 等. 脑卒中偏瘫患者坐-站转移时足位、躯干运动及下肢负重间的关系 [J]. 中国康复理论与实践, 2015, 21(9): 1082-1086.
- 45 胡树罡, 沈滢, 顾晓英, 等. 低频重复经颅磁刺激治疗老年人失眠症的疗效观察 [J]. 中华物理医学与康复杂志, 2018, 40(3):

187-190.

- 46 郑志学, 朱汉民, 王赞舜, et al. 全球人口老龄化新动向 [J]. 中国老年学杂志, 2001, 21(1): 79-80.

收稿日期: 2019-1-10